

МАММОЛОГИЯ

УДК:618.19-006.6

Ш.Ж.Талаева, Н.А.Чичуа, А.С.Манашева,
Ш.С.Султансеитов, А.Я.Тогузбаева, А.Б.Байжигитов, Н.А.Омарбаева
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аннотация. Рак молочной железы (РМЖ) одно из самых распространенных заболеваний в мире, занимающее первое место по заболеваемости и третье по смертности среди злокачественных заболеваний. В Казахстане РМЖ занимает первое место среди других видов злокачественных опухолей.

Цель исследования- улучшение качества жизни пациенток с введением в практику реконструктивно-пластических операций.

Материал и методы. Прооперировано 138 больных РМЖ, которым производилась операция или одномоментная реконструкция молочной железы.

Результаты.. Наиболее предпочтительной оказалась реконструктивно-восстановительная операция. Общая и безрецидивная выживаемость больных РМЖ после радикальной мастэктомии с одномоментная реконструкция не отличалась от выживаемости пациенток без пластических операций. Но такие операция являются важным этапом реабилитации.

Ключевые слова: рак молочной железы,

реконструктивно-пластические операции, качество жизни, выживаемость.

Рак молочной железы - одно из самых распространенных заболеваний среди женщин развитых стран мира, занимающее первое место по заболеваемости и третье по смертности среди злокачественных новообразований в общей популяции. Статистические данные последних лет свидетельствуют о неуклонном, интенсивном росте заболеваемости и смертности от рака молочной железы в различных странах. Ежегодно в мире регистрируется более 1 млн. новых случаев рака молочной железы[1]. У женщин рак молочной железы (РМЖ) в Казахстане, занимает 1 место среди других видов злокачественных новообразований. В среднем в Республике Казахстан ежегодно выявляется около 4000 больных РМЖ, из которых умирают более 1380 женщин. В частности в 2015 г зарегистрировано 4338 новых случаев РМЖ, что составило 25,1 на 100000 населения. Летальность на 1 году жизни составляет 7,9 %, а 5-летняя выживаемость -53,4%[1].

Таблица №1- Динамика развития показателей рака молочной железы в Республики Казахстан за период с 2012 по 2015гг.

	2012	2013	2014	2015
Заболеваемость	23,5	22,7	24,0	25,1
Смертность	8,4	8,2	8,3	7,9
Впервые выявленные	3951	3863	4142	4 4338
Умершие (абс.)	1410	1375	1346	1386
Контингент	27137	28277	29796	31352
5-летняя выж.	51,8	51,4	51,3	53,4

Раку подвержены все возрастные категории людей. Исключительно редко болезнь возникает у молодых женщин до 20 лет, редко до 30 лет, но затем показатели заболеваемости в зависимости от возраста резко увеличиваются и снижаются только после 70 лет. Наибольший риск заболеваемости приходится на возраст 50-60 лет, поэтому около 75% больных составляют женщины в постменопаузе. В 25 лет риск составляет 1:2000, в 55 лет-1:33, в 75 лет-1:11, после 80-1:8 {2}.

Благодаря совершенствованию методов лекарственной и лучевой терапии появилась возможность выполнения различных органосохраняющих оперативных

вмешательств в качестве стандарта при лечении рака молочной железы. Основной целью данных операции является сохранение максимального объема здоровой ткани, внешнего вида и структуры, а также, в случае проведения операции у женщин фертильного возраста, и функциональной активности молочной железы. У пациентов с начальными формами рака молочной железы при относительно небольших размерах опухоли (в среднем до 2.5 см) такой метод обладает неоспоримым преимуществом, т.к. не сопровождается, не приводит к эстетическим дефектам, существенно угнетающим психоэмоциональное состояние женщины, и вызывающее развитие депрессивных

состояний, которые в свою очередь ведут к ухудшению прогноза лечения. Но в ряде случаев существуют противопоказания ограничивающие выполнение органосохраняющих операции, такие как, большие размеры первичной опухоли при небольшой молочной железе, внутримаммарный или мультифокальный рост опухоли, локализация опухоли вблизи сосково-ареолярного комплекса и т.д. В таких случаях производится радикальная мастэктомия по различным модификациям, что является для женщины не только травматичной, но и серьезной психологической травмой[2].

Потеря молочной железы после радикального лечения по поводу рака представляет не только физический недостаток, но и является для женщин серьезной психической травмой, которая оказывает решающее воздействие на ее поведение в быту и обществе. Как показывает анализ социально-психологического статуса, 30% этих женщин не могут смириться с потерей молочной железы. Медикаментозная терапия и наружное протезирование не устраняют депрессивного состояния у этой категории больных, выключая их из активной социально-трудовой деятельности.

Цель исследования - улучшение качества жизни пациентов с введением в практику реконструктивно-пластических операции при раке молочной железы.

В последние годы все большее значение уделяется вопросам качества жизни больных, их социальной и психологической реабилитации.

В 1978 г. ВОЗ было разработано определение здоровья как «состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие заболевания и физической не-состоятельности». В связи с этим возрастает значение реконструктивно-пластических операций при злокачественных новообразованиях молочной

железы.

Материалы и методы исследования. В Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии реконструктивно-пластические операции начали выполняться с 2009г. По сроку осуществления реконструктивно-восстановительные операции выполнялись одномоментно или отсрочено после мастэктомии. Отсроченная пластическая маммопластика производилась через некоторое время после радикальной операции. По способу осуществления в основном применялась аллопластика (реконструкция с помощью эндопротезов), реже аутопластика (реконструкция с помощью собственных тканей), а также их комбинации. Выбор метода реконструкции зависел от стадии заболевания, планируемого или выполненного типа радикального вмешательства, вовлеченности в патологический процесс мягких тканей (кожи, клетчатки и мышц), общего состояния здоровья пациентки и пожеланием пациентки. Все модификации доказали свою онкологическую безопасность и создали возможности для значительного улучшения окончательных эстетических результатов.

Настоящая работа основана на анализе результатов хирургического лечения 138 больных с 2009 по 2015 годы, которым производилась отсроченная или одномоментная реконструкция молочной железы в комплексном лечении РМЖ в Маммологическом Центре Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Средний возраст пациенток составил 47,6 года. Абсолютное большинство (83%) больных находились в наиболее трудоспособном возрасте — от 34 до 52 лет. Одностороннее поражение наблюдалось у 96%, и лишь у 4% пациенток отмечалось двустороннее поражение. Для отсроченной реконструкции больные поступали в сроки от полугода до 5 лет после радикальной мастэктомии.

Таблица 2 – Виды реконструкция молочной железы, проведенные с 2009 по 2015 годы

Срок операции	Вид операции	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	ИТОГО
Одномоментная реконструкция	Аллопластика эндопротезом		5	6	8	18	41	39	117
	Аутопластика TRAM лоскутом	2	2	1	1	2			8
	Комбинированный метод				2				2
	Экспандер						2	2	4
Отсроченная реконструкция	Аутопластика TRAM лоскутом			1	1	2			4
	Комбинированный метод				1				1
	Экспандер					2		2	4
Итого:	140								

Одномоментная имплантация молочной железы являлась наиболее популярным методом, что составило 83.5 % (117 пациентов) от всех примененных методов реконструкции. Для этого вида использовался постоянный эндопротез, с сохранением кожи (skin-sparing mastectomy) и удалением лимфатических узлов I–III уровня.

Одномоментная реконструкция в 95% случаев была выполнена с сохранением соскового-ареолярного комплекса.

Пример 1. Пациентка 39 лет, диагноз - рак правой мо-

лочной железы, T2N2M0, StIIa, узловая форма. Состояние после 4х курсов НАПХТ.

Объем операции - кожесосоксберегающая мастэктомия с лимфаденоэктомией и одномоментной реконструкцией эндопротезом справа, профилактическая мастэктомия слева. В данном примере отчетливо отражена динамика развития послеоперационного хода опущения имплантатов до субмаммарной складки, что в конце дает ожидаемый эстетический вид.



1 фото – Вид до операции: 2 фото – 1 –е сутки после операции, нижнее фото - 2 месяца с момента операции

Пример 2: Пациентка 45 лет с диагнозом: рак левой молочной железы. T2N1M0. St IIB. Узловая форма. Состояние после 4х курсов НАПХТ

Объем операции: Кожесосоксберегающая мастэк-

томия с лимфаденоэктомией и одномоментной реконструкцией эндопротезом справа, профилактическая мастэктомия слева.

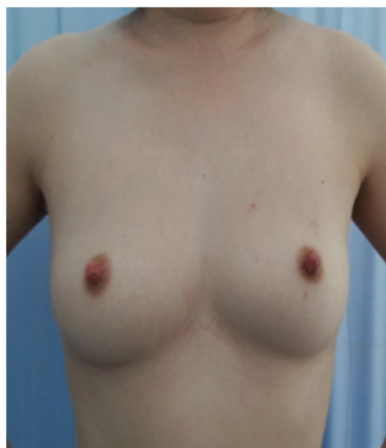


Вид до операции

10-е сутки после операции

Пример 3: Пациентка 33 лет, с диагнозом: рак левой молочной железы. T2N1M0. St IIB. Узловая форма. Состояние после 4х курсов НАПХТ

Объем операции: Кожесосоксберегающая мастэктомия с лимфаденоэктомией и одномоментной реконструкцией эндопротезом слева.



Вид спереди до операции



1-е сутки после операции

Пример 4. Пациентка 36 лет., с диагнозом: рак левой молочной железы. T2N1M0. St IIB. Узловая форма. Состояние после 4х курсов НАПХТ

Объем операции: Кожесосоксберегающая мастэктомия с лимфаденоэктомией и одномоментной реконструкцией эндопротезом слева. Мастопексия справа

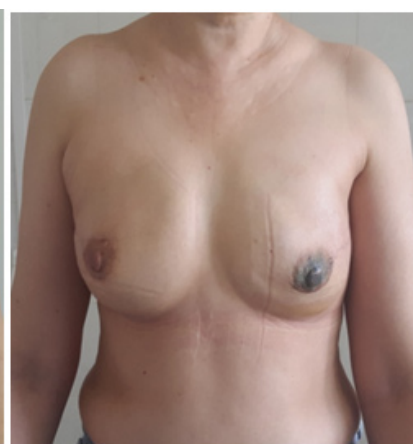


Пример 5: Пациентка 52 лет., с диагнозом: рак левой молочной железы. T1N0M0. St I. Узловая форма. Верхне-наружный квадрант

Объем операции: Кожесосоксберегающая мастэктомия с лимфаденоэктомией и одномоментной реконструкцией эндопротезом слева. Профилактическая мастэктомия справа.



Вид спереди до операции



2 месяца после операции

Одномоментная реконструкция молочной железы TRAM-лоскутом выполнено у 12 женщин (8.5%). Данная методика позволяет наиболее эстетично создать контур молочной железы с хорошо выраженной субмаммарной складкой. В последующем на участок пересаженного ложа выполняется реконструкция соска кожным лоскутом.

Пример 6. Пациентка 53 л., с диагнозом: рак правой молочной железы St IIIB (T4N2M0). Язвенно-некротическая форма. Состояние после комплексного лечения.

Объем операции: Радикальная мастэктомия с одномоментной реконструкцией TRAM лоскутом справа



Вид после операции год спустя



Вид после реконструкции соска кожным лоскутом

Комбинированные отсроченные методы, включающие в себя использование собственных тканей (лоскут широчайшей мышцы спины) и искусственных протезов (имплантат) было выполнено у 3 женщин (2.1%).

ТДМ-лоскут является надежным и не слишком травматичным по сравнению с TRAM-лоскутом, но чаще всего применялся в сочетании с имплантатом, так как максимальный объем ЛДМ-лоскута, который может быть моби-

лизован без серьезного ущерба донорской зоны, обычно не превышает 200–300 см³. (рис. №7) .

Пример 7. Пациентка, 53 года, с диагнозом: рак правой молочной железы St IIB (T2N1M0). Узловая форма. Состояние после 6 курсов НАПХТ.

Операция: одномоментная реконструкция ТДЛ- лоскутом в комбинации с эндопротезом.



Вид спереди Вид сбоку



Ранний послеоперационный период

Эндопротезирование с предварительной установкой экспандера (пример 8) было выполнено 8 пациенткам (5.7%). Экспандер чаще устанавливается после радикальных мастэктомии как отсроченная операция для растяжения тканей с последующей заменой на постоянный эндопротез. Метод подразумевал двухэтапность реконструкции, когда на первом этапе имплантировался тканевой экспандер, в послеоперационном периоде в течение 4–6 мес производилось его растяжение и окружающих тканей путем введения стерильного изотонического раствора NaCl. После достижения необходимого объема, который обычно превышает объем планируемой железы

примерно на одну треть, выполнялся второй этап реконструкции, заключающийся в замене экспандера на постоянный эндопротез, формировании, если это необходимо, новой субмаммарной складки, сосково-ареолярного комплекса, а также коррекции противоположной молочной железы.

Пример 8. Пациентка 45 л., с диагнозом: рак левой молочной железы St IIIB (T4N1M0). Отечно-инфильтративная форма. Состояние после комплексного лечения.

Объем операции: Отсроченная реконструкция левой молочной железы экспандером и сосково-ареолярного комплекса.



Вид до операции

6 месяцев спустя



Реконструкция соска кожным лоскутом

Окончательный результат после татуажа сосково-ареолярного комплекса

Вывод. Наиболее предпочтительным для женщин одномоментная реконструктивно-восстановительная операция, в связи с отсутствием повторного хирургического вмешательства и минимальным эмоциональным дискомфортом. Выполнение данных оперативных вмешательств не влияет на сроки проведения адъювантной терапии. Общая и безрецидивная выживаемость больных РМЖ после радикальной мастэктомии с одномоментной реконструкцией не отличаются от выживаемости пациенток без пластической операции. Не менее важен психологический аспект, когда отсутствует промежуток от нескольких месяцев до нескольких лет без молочной железы. Косметические преимущества одномоментного хирургического

лечения и восстановления также понятны: отсутствие дополнительных рубцов, повторных разрезов с последующим дефицитом кожного покрова, возможность сохранения субмаммарной складки и короткий койко-день[3].

В заключение хотелось бы отметить, что реконструктивные операции, выполняемые у больных РМЖ, являются важным этапом реабилитации. Одномоментную реконструкцию считаем наиболее предпочтительной и в техническом плане, и в психологическом, а из множества методик реконструкции молочной железы мы отдаем предпочтение одномоментной реконструкции эндопротезом.

Список литературы

1. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2015 г. (статистические материалы).- Алматы, 2015. –91 с.
2. Руководство по клинической онкология / под редакц. Нургазиев К.Ш.- 1 том, раздел рак молочной железы.- Алматы, 2016.
3. Ю.С. Егоров, О.В. Крохина, В.А. Соболевский, Н.Р. Халитова. ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва. RECONSTRUCTIVE INTERVENTION VERSIONS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER. Материалы из журнала "Маммология".- 2006.-№3.

Тужырым

**Ш.Ж.Талаева, Н.А.Чичау, А.С.Манашева,
Ш.С.Султансеитов, А.Я.Тогузбаева, А.Б.Байжигитов,
Н.А.Омарбаева**
**Қазақтың онкология и радиология ғылыми-зерттеу
институты**

**Сүт безі қатерлі ісігі кезіндегі реконструктивті-
пластикалық операцияларды қолданудағы
тәжірибесі**

Сүт безі қатерлі ісігі дүние жүзінде кеңінен таралған аурудың бірі болып табылады, сондай-ақ аурулардың ішінен бірінші орын алып, қатерлі ісіктер арасында өлім көрсеткіші бойынша үшінші орын алады. Қазақстанда сүт безі қатерлі ісігі басқа қатерлі ісіктер арасында бірінші орын алады.

Зерттеудің мақсаты - реконструктивті-пластикалық операцияларды тәжірибеге еңгізгеннен науқастардың өмір сапасын жақсарту.

Материал және әдістемелер. Сүт безі қатерлі ісігі бар 138 науқасқа операция және де бір мезеттік сүт безінің реконструкциясы жасалды.

Нәтижелер. Көпшілікті реконструктивті-қалпына келтіру операциялардың артықшылығы байқалды. Сүт безі қатерлі ісігі кезінде радикалды мастэктомия бір мезетті реконструкция операциясы жасалған науқастарда, пластикалық операциялар жасалмаған науқастардың жалпы және рецидивсіз өміршеңдігінің айырмашылығы байқалған жоқ. Бірақ мұндай операциялар реабилитациялық кезеңнің маңызды өкілі болып саналады.

Түйінді сөздер: Сүт безі қатерлі ісігі, реконструктивті-пластикалық операциялар, өмір сапасы, өміршеңдік.

SUMMARY

**Sh.Z.Talayeva, N.A.Chichua, A.Manasheva, S.Sultanseitov,
A.Toguzabayeva, A. Baizhigitov, N. Omarbayeva**
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

**Experience of the reconstructive surgery in patients with
breast cancer**

Breast cancer (BC) one of the most common diseases in the world holding the first place on morbidity and the third on mortality among malignant diseases. In Kazakhstan BC takes the first place among the other types of malignant tumors.

The purpose of the study and the improvement of the quality of life of patients with the introduction of the practice of rendered aid but also help doctors-plastic operations.

Material and methods. The surgeries are unique 138 of BC patients, who was the operation or одномоментная reconstruction breast cancer.

The results. The most preferred was rendered aid but also help doctors-replacement operation. Overall and disease free survival of BC patients after radical mastectomy with immediately reconstruction does not differ from the survival of patients without plastic operations. But such an operation is an important step in rehabilitation.

Key words: breast cancer, reconstructive surgery, quality of life, survival.